Árbol de decisión — Codo

PhysiQ-Assessment · fase 4 · Codo. Cada respuesta puede sumar una hipótesis; se acumulan y todas se confirman con tests en la fase 4b.

REQUISITO PREVIO · Banderas rojas (fase 1) y cribado sistémico (fase 2). Si hay una urgencia, derivar: este árbol no se aplica.

1 ¿Hubo un evento traumático, hay deformidad muscular característica o es un niño o adolescente?

Respuestas

SÍ
Pérdida del contorno normal del brazo (a veces sutil), hinchazón y debilidad en flexión/supinación → **7 Rotura Distal del Bíceps**

FRACTURA / LUXACIÓN
Caída o golpe con deformidad del codo, o el codo no llega a estirarse del todo: sospecha de fractura o luxación → derivación médica
→ **Derivación médica**
Sospecha de fractura o luxación tras un traumatismo (deformidad, o el codo no llega a estirarse del todo: casi un 50 % de fracturas en Appelboam 2008): derivación médica para radiografía; antes, explorar la sensibilidad, el color y la temperatura de la mano.

NIÑO O ADOLESCENTE
Esqueleto inmaduro: tirón del brazo extendido en un menor de 5 años, lanzador joven con dolor medial, o dolor lateral insidioso entre los 7 y los 12 años →
- **14 Pronación Dolorosa (Subluxación de la Cabeza del Radio en el Niño)**
- **15 Codo de la Liga Infantil (Apofisitis o Avulsión del Epicóndilo Medial en el Lanzador Joven)**
- **16 Enfermedad de Panner / Osteocondritis Disecante del Capítulo**

NO
Sin traumatismo significativo ni deformidad → sin hipótesis

todas

2 ¿Existe una restricción GLOBAL y dolorosa de todos los movimientos del codo (flexión, extensión, pronación, supinación)?

Respuestas

SÍ
Limitación activa y pasiva en todos los planos → **3 Rigidez del Codo (Contractura Postraumática o Capsular)**

NO
Movilidad mayormente preservada → sin hipótesis

todas

3 ¿Presenta parestesias, debilidad intrínseca de la mano o dolor quemante en el antebrazo?

Respuestas

SÍ
Zona medial: parestesias en 4º y 5º dedo, Tinel positivo en surco epitrócleo-olecraniano → **8 Neuropatía Cubital (Síndrome del Túnel Cubital)**

SÍ
Zona dorsal/lateral: dolor en el dorso del antebrazo proximal, distal al epicóndilo, o debilidad para extender los dedos → **9 Neuropatía Radial en el Codo (Síndrome del Túnel Radial / del Nervio Interóseo Posterior)**

SÍ
Zona anterior: dolor en el antebrazo anterior, parestesias del 1.º al 3.º dedo o debilidad de la flexión del pulgar y del índice → **13 Neuropatía del Mediano en el Codo (Síndrome del Pronador / del Nervio Interóseo Anterior)**

NO
Sin síntomas neurales → sin hipótesis

continúa en la página siguiente →

4 ¿El dolor es puntual al cargar peso o realizar agarres? ¿Dónde se localiza?

Respuestas

Epicóndilo lateral
Dolor con extensión resistida de muñeca (Test de Cozen) y dolor en cara lateral
→ **1 Tendinopatía Lateral (Epicondilalgia Lateral / Codo de Tenista)**

Epicóndilo medial
Dolor con flexión resistida de muñeca y pronación, dolor en cara medial
→ **2 Tendinopatía Medial (Epicondilalgia Medial / Codo de Golfista)**

Cara posterior
Dolor en la extensión terminal o con la extensión resistida del codo
→ **10 Tendinopatía o Rotura del Tríceps**
→ **11 Pinzamiento Posterior o Posteromedial (Sobrecarga en Extensión-Valgo)**
→ **12 Fractura de Estrés del Olécranon**

Sin localización epicondílea clara
→ sin hipótesis

todas

5 ¿Siente que el codo "falla" o tiene bloqueos?

Respuestas

Inestabilidad medial
Dolor al estrés en valgo en deportistas de lanzamiento
→ **4 Insuficiencia del Ligamento Colateral Cubital (LCC)**

Inestabilidad posterolateral
Sensación de fallo con carga en supinación/extensión
→ **5 Lesión del Complejo Colateral Lateral / Inestabilidad Rotatoria Posterolateral (IRPL)**

Bloqueo/Chasquido
Dolor posterolateral en extensión terminal
→ **6 Dolor Radiohumeral / Pinzamiento Posterolateral por Plica Radiocapitelar**

Sin inestabilidad ni bloqueos
→ sin hipótesis

Leyenda
- Pregunta del árbol
- Hipótesis que activa la respuesta
- Derivación médica (el recorrido sigue)
- Sin hipótesis

Al terminar sin ninguna hipótesis activa
La app propone trabajar con «dolor de codo inespecífico», revisar los factores psicosociales (fase 1 y SINSS) y reconsiderar las respuestas. Si el cuadro es crónico y el riesgo psicosocial es alto, sugiere considerar también sensibilización central.

Fase 4b · confirmar
Cada hipótesis activa se confirma o descarta con sus tests: ver el esquema de confirmación de codo.

Generado desde los datos de la app el 30/10/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0